

Uważność *adaptowana*

Mindfulness w psychozie jest bezpieczna i skuteczna — pod warunkiem adaptacji. Krótka, oczy otwarte, kotwica zewnętrzna. Cel: decentracja, nie eliminacja.

CZAS: 10–15 min praktyki Po stabilizacji · z prowadzącym

ŹRÓDŁO: Chadwick (2006, PBCT; 2014); Bach & Hayes (2002, ACT-p); Khoury (2013, meta-analiza)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **pięć adaptacji mindfulness** do psychozy (sekcja 1) i wypróbuj *krótką praktykę zakotwiczenia* (sekcja 2). W sekcji 3 zaplanuj, jak chcesz włączyć uważność w swój dzień. Zaczynaj od 5 minut — nie 30.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Khoury i in. (2013, meta-analiza 13 badań): *mindfulness* adaptowany redukuje objawy psychotyczne ($d = 0,52$) i poprawia funkcjonowanie. Chadwick (2014): standardowy MBSR **nie jest bezpieczny** w psychozie (długie sesje, zamknięte oczy mogą nasilać halucynacje), ale adaptacja działa. Mechanizm: **decentracja** — „słyszę głos, to doświadczenie, nie ja”. Pacjent uczy się obserwować objawy z dystansu, zamiast walczyć lub ulegać. Bach & Hayes (2002, RCT ACT dla psychozy): jedno- lub dwusesyjna interwencja oparta na akceptacji **redukuje rehospitalizacje o połowę**.

01 Pięć adaptacji do psychozy

1 · KRÓTKIE SESJE

5–15 minut, nie 30–45. Długie sesje mogą nasilać objawy. Krótka, częsta praktyka skuteczniejsza.

2 · OCZY OTWARTE

Zamknięte oczy mogą wywoływać lub nasilać halucynacje wzrokowe. Otwarte oczy + miękki wzrok w jeden punkt.

3 · KOTWICA ZEWNĘTRZNA

Dźwięki, dotyk nóg na podłodze — zamiast oddechu. Oddech bywa wyzwalaczem lęku u osób z paranoją.

4 · BRAK DŁUGIEGO MILCZENIA

Prowadzący *mówi przez całą sesję* — nawet 30-sekundowe ciche pauzy mogą być trudne. Ciągłe, łagodne instrukcje.

5 · PRAWO DO PRZERWANIA

Jeśli pojawia się dyskomfort — **masz prawo przerwać**. To nie porażka. *Mindfulness* ma być narzędziem regulacji, nie próbą wytrzymałości. Praktyka grupowa często bezpieczniejsza niż indywidualna.

02 Praktyka zakotwiczenia 5–4–3–2–1

Ćwiczenie używane także w pracy z lękiem i traumą. Bezpieczne, krótkie (2–3 min), prowadzi *na zewnątrz* głowy. Można wykonać w autobusie, w pracy, gdy nasilają się głosy lub urojenia.

5 rzeczy, które widzisz — kolory, kształty, faktury wokół Ciebie

4 rzeczy, które słyszysz — dźwięki bliskie i dalekie

3 rzeczy, które czujesz dotykiem — ubranie, krzesło, podłoga pod stopami

2 zapachy — albo świadomość ich braku

1 smak — w ustach, na języku

Wracaj do kotwicy, gdy uwaga ucieka. Nie próbuj *nie myśleć* — pozwól myślom przychodzić i odchodzić, wracając do tego, co widzisz/słyszysz.

03 Mindfulness gdy słyszysz głos

Gdy głos się pojawia, naturalna reakcja to *walka* („*idź sobie!*”) albo *uległość* („*muszę słuchać*”). Mindfulness oferuje trzecią drogę: **obserwację z dystansu**.

ZAUWAŻ

„Słyszę głos. Mówi X. To jest doświadczenie”. Nazwanie tworzy dystans między Tobą a głosem.

NIE WALCZ, NIE ULEGAJ

Pozwól głosowi *być*. Walka go wzmacnia. Uległość mu daje władzę. Środkowa droga: obserwacja.

WRÓĆ DO KOTWICY

Po nazwaniu — wróć do tego, co robiłeś/-aś. Dźwięki w pokoju, stopy na podłodze. Życie toczy się dalej.

04 Mój plan praktyki

KIEDY I GDZIE BĘDĘ PRAKTYKOWAĆ

— konkretna pora, miejsce, długość (zaczynij od 5 min)

CO ZROBIĘ, GDY POJAWI SIĘ DYSKOMFORT

— sygnał, że mam przerwać; do kogo zadzwonię

-------------	-------------

Klucz: Bach & Hayes (2002, RCT z 80 pacjentami): krótka interwencja oparta na akceptacji (4 sesje) **zmniejszyła rehospitalizacje o 50%** w ciągu 4 miesięcy. Mechanizm: nie redukcja objawów, lecz *zmiana relacji* z nimi. Pacjenci doświadczali głosów i urojeń w podobnej częstotliwości, ale **mniej cierpieli**. Chadwick (2006) w „*Person-Based Cognitive Therapy*” pokazuje, że to **akceptacja doświadczenia**, nie walka z nim, otwiera przestrzeń na zdrowienie. Mindfulness w psychozie jest *uzupełnieniem* CBTp i farmakoterapii — nie zastępuje ich.